



SUPERVISÃO CLÍNICA · LÓGICA PSICOLÓGICA

# Autocrítica acadêmica

*Uma adolescente que se considera uma farsa. A supervisão mostra por que deslocar a culpa não basta — e como trabalhar a própria definição da palavra que sustenta o self.*

PROFESSOR E PSICÓLOGO CLÍNICO

**Júlio Gonçalves**

MSc · CRP 12/17614

Aprenda muito mais na

## Comunidade Lógica Psicológica

**Uma comunidade para quem quer:**

- Ψ **Aprofundar o raciocínio clínico** com conteúdos que unem ciência, processos e análise funcional.
- Ψ **Estruturar uma prática ética e coerente**, com pensamento crítico e evidências atualizadas.
- Ψ **Desenvolver o self clínico** por meio de supervisão, leituras guiadas e construção em rede.

[Clique aqui e saiba mais](#)



## O ESSENCIAL

- Ψ **“Farsa” implica enganar de propósito.** É por isso que a palavra gruda em quem guardou segredo na infância — e é por aí que se desmonta a crença.
- Ψ **Não basta dizer que a culpa não é dela.** O trabalho é mostrar como a experiência moldou historicamente a sensação de ser uma farsa. Deslocar culpa sem explicar origem não sustenta.
- Ψ **Um self rígido demais para a idade.** E um ambiente novo, mais formal e exigente, que vinha refinando esse self em vez de afrouxá-lo.
- Ψ **Carência é necessidade humana, não defeito.** Ela lutava contra a própria carência por associá-la ao passado. Normalizar é intervenção, não consolo.
- Ψ **Dificuldade de aplicar não é recusa de melhorar.** Ler a não adesão como “escolha de não se ajudar” devolve culpa a quem já se culpa de tudo.

## O caso, em uma página

Adolescente que migrou com a família para outro país há menos de um ano, tendo perdido o pai ainda na infância. Procurou terapia por **dificuldades escolares**, com episódios de choro; recebeu apoio psicológico e adaptações educacionais na escola, que não aproveitou plenamente.

O contexto escolar era desfavorável de saída: ela entrou num sistema com calendário, organização e critérios de avaliação diferentes dos que conhecia, num ponto do percurso em que o conteúdo já era mais avançado. Os professores a descreviam como **dedicada e esforçada**, apontando a falta de base de conteúdo como a dificuldade principal.

Ela lia a mesma situação de outro jeito: culpava-se por ter escolhido permanecer no nível em que estava, quando havia a opção de recuar um ano — e se via como **uma farsa**.

## O que melhorou por mudança de contexto

A primeira fase da terapia foi descrita como “apagar incêndio”: ela chegava às sessões muito sensibilizada, morando num arranjo com pouca privacidade. Depois de uma mudança que reduziu o número de pessoas na casa e trouxe uma rotina menos intensa, ela passou a chegar menos ativada.

#### Um dado que vale registrar

Parte relevante da melhora inicial veio de **alteração de contexto**, não de técnica. Privacidade e rotina menos sobrecarregada mudaram a linha de base — e só a partir daí o trabalho clínico pôde deixar de ser contenção. Vale lembrar disso antes de atribuir a estabilização a uma intervenção específica.

## A crença de ser uma farsa

O trabalho terapêutico se organizou em torno de metas de estudo irreais, expectativa altíssima de desempenho e um **foco atencional intenso no negativo**. A régua era severa a ponto de ela se considerar uma farsa se *não realizasse uma tarefa com a motivação ideal* — não bastava fazer; era preciso querer fazer do jeito certo.

Ao longo do processo de flexibilização, emergiram lembranças de infância que ajudaram a explicar de onde vinha aquela palavra. Entre elas, **experiências de violência sofridas quando ela era muito pequena**, que deixaram a sensação de ser uma farsa e de estar suja. E uma memória de sentir-se **inconveniente** numa atividade extracurricular, que a levou a regular excessivamente o próprio comportamento e a atribuir as dificuldades escolares a problemas de conduta — e não de conteúdo.

#### O reenquadre que a supervisão propôs

A tentação é focar em **deslocar a culpa** — dizer que ela não teve responsabilidade pelo que sofreu. Necessário, mas insuficiente. O trabalho mais potente é mostrar **como a experiência moldou historicamente a sensação de ser uma farsa**.

E há uma chave semântica que abre isso: *farsa* implica **enganar de propósito**. A palavra gruda porque ela guardou segredo — e passou a ler o próprio silêncio como engano deliberado. Manter segredo, porém, é das consequências mais comuns e mais bem descritas da violência sofrida na infância, muitas vezes induzida por quem a praticou. Não é engano: é efeito.

Uma intervenção já realizada e bem escolhida: o uso do **boletim** para demonstrar concretamente que a dificuldade era de conteúdo, e não comportamental. A procrastinação, por sua vez, foi ligada ao **medo de ser vista estudando** — e de, com isso, ser considerada uma farsa por não ser tão inteligente quanto os outros.

Vale nomear o parentesco: essa é a estrutura clássica do **fenômeno do impostor** — sucesso atribuído a esforço ou sorte, com medo constante de ser desmascarado. Reconhecer o padrão ajuda a mostrar à paciente que ele não é exclusividade dela.

## Deslocar a responsabilidade sem deixar buraco

### Contexto sociocultural

Foi proposto explicar o *self* a partir do contexto — deslocando a responsabilidade da paciente para o ambiente e para os adultos que deveriam tê-la protegido. E há um agravante contextual atual: um ambiente cultural mais formal e mais exigente quanto a regras vinha **refinando um self já autocrítico**, em vez de afrouxá-lo. Somado ao estresse de adaptação a um país novo, o quadro se sustentava sozinho.

### A analogia do repertório

Para explicar por que ela não podia ser responsabilizada, a estratégia foi usar **analogias sobre falta de repertório**: uma criança pequena diante de uma situação que não tem meios de compreender não dispõe da consciência crítica necessária para avaliá-la — e, portanto, não pode ser cobrada por ela.

A terapeuta já vinha usando um recurso desse tipo com bom efeito: comparou a situação à de uma criança pequena da família com uma condição crônica de saúde, para questionar se seria justo cobrar dessa criança consciência sobre algo que ela não tinha como ter. A comparação flexibilizou a autocrítica.

### Normalizar a carência

Um achado importante: ela **luta contra os próprios sentimentos de carência** e evita envolvimento afetivo, porque associa a carência aos episódios difíceis do passado — inclusive a um contato inadequado ocorrido por meio digital quando era criança, pelo qual também se culpa. É um conflito com o *self* imperfeito: sentir necessidade de afeto virou, para ela, prova de que há algo errado consigo.

#### A intervenção, dita com clareza

**Normalizar a carência como necessidade humana**, ligando-a à perda do pai e à necessidade de proteção que qualquer pessoa tem — e mais ainda quem perdeu cedo uma figura de cuidado.

E, sobre o contato ocorrido na infância, o mesmo princípio que vale para tudo neste caso: **a responsabilidade é do adulto**. Uma criança que buscava afeto não é responsável pelo que um adulto fez com essa busca.

Também foi usada, com bons resultados, a **técnica da cadeira** — para ajudá-la a perdoar a criança que ela foi.

## Trabalhar a palavra: o que é uma farsa

Uma tarefa concreta e elegante saiu da supervisão: pedir que a paciente **defina “farsa” com as próprias palavras** — a definição que o cérebro dela usa —, e depois compare com a **definição do dicionário**.

Feita a comparação, avaliar o comportamento dela à luz das duas. O objetivo é mostrar que a autoavaliação é mais uma **sensação, culturalmente induzida e historicamente construída**, do que uma descrição da realidade.

### Por que isso funciona melhor que discutir evidência

Discutir se ela é ou não uma farsa aceita o termo dela e disputa o veredito. Definir o termo muda o terreno: mostra que a palavra que ela usa **não descreve o que ela faz**. É reestruturação operando sobre o conceito, não sobre o conteúdo — e costuma escapar da armadilha em que o paciente se critica por “estar distorcendo”.

## Comportamento gradual e monitoramento

A procrastinação foi lida como **fruto do self rígido**, e não como preguiça ou desorganização — o que muda a intervenção.

### O exercício das duas vidas

Trabalhar, em termos comportamentais, a **vida que ela aparenta ter** versus a **vida que quer ter**, com foco em reduzir a sensação de ser uma farsa. É o mesmo movimento de valores visto no encontro sobre processos motivacionais, adaptado à idade e ao caso.

### Começar pelo que não é aversivo

- Ψ **Iniciar com tarefas de baixo custo**, fora do contexto escolar aversivo — ler ou organizar livros que ela goste, por exemplo.
- Ψ **Aumentar a dificuldade gradualmente**, e não por salto.
- Ψ **Monitorar o desempenho** ao longo do tempo, com registro.

O monitoramento tem função específica aqui, e não é burocracia: ele permite que ela veja os ganhos de forma **agregada**. Para alguém com foco atencional preso ao negativo, o gráfico faz o que a memória não faz — mostra a série inteira em vez do último ponto. É por aí que a autoeficácia e a autoimagem melhoram.

## Perspectiva de tempo, e a conta da repetição

Dois recursos de enquadramento fecharam a discussão. Um **exercício de linha do tempo**, mostrando que, mesmo com os erros que ela atribui a si, ainda há muito tempo pela frente para construir a vida que deseja. E um exemplo de autorrevelação — a dança foi o usado — para deixar claro que **qualidade vem de milhares de repetições, não de talento nato**. Quem ainda não repetiu o suficiente não é uma farsa: é alguém no começo.

## Uma correção de leitura, e o que fica

Há um momento da supervisão que vale destacar por si.

A terapeuta observou que a paciente tem repertório e consegue questionar os próprios pensamentos, mas ainda tem dificuldade de aplicar as estratégias na prática — e interpretou isso como **“uma escolha para não se ajudar”**.

### O reenquadre

A leitura devolvida foi outra: para a idade dela, **o self é muito rígido**, e a dificuldade de aplicar é efeito dessa rigidez — não recusa de melhorar.

A distinção não é sutil. Ler a não adesão como escolha devolve culpa a alguém cujo problema central é justamente se culpar de tudo — e faz o terapeuta repetir, dentro da sessão, a operação que adoece a paciente. É a mesma advertência que o capítulo sobre aceitação faz a respeito da palavra “resistência”: o rótulo cria distância e transfere ao paciente uma responsabilidade que é da transação.

## O que fica para a sua clínica

- Ψ **Trabalhe a palavra, não só a evidência.** Definir o termo que o paciente usa costuma render mais que discutir se ele é verdadeiro.
- Ψ **Deslocar culpa não basta.** Explique como a experiência produziu a crença — senão o alívio não se sustenta.
- Ψ **Segredo não é engano.** Guardar silêncio sobre violência sofrida na infância é efeito comum, frequentemente induzido — e nomear isso desmonta a acusação que o paciente faz a si.
- Ψ **Normalize a necessidade de afeto** em quem aprendeu a tratá-la como defeito.
- Ψ **Monitore de forma agregada.** Quem tem foco preso no negativo precisa ver a série, não o último ponto.
- Ψ **Cuidado com “ele não quer se ajudar”.** Quase sempre é rigidez, medo ou falta de repertório — e o rótulo custa o vínculo.

## Referências

1. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.
2. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34.
3. Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 15(3), 241–247.
4. Feiring, C., Taska, L., & Lewis, M. (2002). Adjustment following sexual abuse discovery: The role of shame and attributional style. *Developmental Psychology*, 38(1), 79–92.
5. Finkelhor, D., & Browne, A. (1985). The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization. *American Journal of Orthopsychiatry*, 55(4), 530–541.
6. Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. *British Journal of Clinical Psychology*, 53(1), 6–41.
7. Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment. *Clinical Psychology Review*, 82, 101908.
8. London, K., Bruck, M., Ceci, S. J., & Shuman, D. W. (2005). Disclosure of child sexual abuse: What does the research tell us about the ways that children tell? *Psychology, Public Policy, and Law*, 11(1), 194–226.
9. Miller, W. R., & Moyers, T. B. (2021). *Effective psychotherapists: Clinical skills that improve regular practice*. Guilford Press.
10. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. Guilford Press.

### NOTA DE MÉTODO

Material de estudo com **desidentificação ampliada**, por envolver uma adolescente. Foram removidos ou substituídos: idade, país e cidade de origem e de destino, calendário e sistema escolar, arranjo de moradia, composição familiar detalhada, atividades específicas, plataformas citadas e marcadores temporais que permitissem reconstruir a trajetória. As experiências de violência sofridas na infância são referidas **apenas pela função que cumprem na formulação**, sem tipo, idade, circunstância ou detalhe de qualquer natureza — nenhum deles acrescentaria ao raciocínio clínico, e todos aproximariam da identificação. Três acréscimos foram feitos ao que a supervisão discutiu. Primeiro: a manutenção de segredo é consequência bem descrita da violência sofrida na infância, frequentemente induzida por quem a pratica — informação que sustenta diretamente o trabalho sobre a palavra “farsa”. Segundo: o padrão descrito corresponde ao **fenômeno do impostor**, e nomeá-lo ajuda a mostrar à paciente que não é caso isolado. Terceiro: o estresse de aculturação foi explicitado como fator contextual. A leitura da terapeuta de que a dificuldade de aplicar as estratégias seria “uma escolha para não se ajudar” está registrada porque a **correção dela é o ponto formativo** do encontro, e não para expor quem a formulou. Os assuntos operacionais foram omitidos; o nome da terapeuta supervisionada e dos demais participantes não é mencionado. As referências foram acrescentadas para dar respaldo formal a conceitos discutidos sem citação explícita; nenhuma citação foi construída para preencher lacuna. Este material registra raciocínio clínico de supervisão e **não substitui** avaliação individualizada.



# Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão — e salve o PDF para acompanhar.

- ☐ Pedi ao paciente que definisse, com as próprias palavras, o termo que ele usa contra si.
- ☐ Expliquei como a história produziu a crença, e não apenas que a culpa não é dele.
- ☐ Nomeei o segredo como efeito da violência, e não como engano deliberado.
- ☐ Atribuí a responsabilidade ao adulto, de forma explícita e repetida.
- ☐ Normalizei a necessidade de afeto em vez de tratá-la como tema secundário.
- ☐ Verifiquei se parte da melhora veio de mudança de contexto, e não de técnica.
- ☐ Comecei pelas tarefas de menor custo, fora do contexto aversivo.
- ☐ Montei um registro que mostra os ganhos de forma agregada.
- ☐ Checei se estou lendo dificuldade de aplicar como recusa de melhorar.

## MINHAS ANOTAÇÕES — O QUE LEVO PARA A CLÍNICA

# Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O PDF guarda o que você escrever.

**1. Que palavra um paciente seu usa contra si mesmo? Como você trabalharia a definição dela?**

**2. Explique, para um caso seu, como a história produziu a crença — sem apenas dizer que a culpa não é dele.**

**3. Como você abordaria, com um paciente adulto, a culpa que ele carrega por ter guardado segredo na infância?**

**4. Que paciente seu trata a própria necessidade de afeto como defeito? Como você normalizaria isso?**

**5. Que parte da melhora de um caso seu veio de mudança de contexto, e não do que você fez?**

**6. Que primeira tarefa de baixo custo você proporia a um paciente que evita o contexto inteiro?**

**7. Em que caso você pensou “ele não quer se ajudar”? Que leitura alternativa cabe ali?**